

Covid19 : les chiffres, les questions, les stratégies

Une fois encore l'évolution de la pandémie - mesurée par des indicateurs dont nous avons déjà parlé, et qui n'ont pas fondamentalement changé de nature - a provoqué des décisions gouvernementales dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Alors, on cherche à comprendre. Or si l'image retenue est toujours celle de la nécessité de contenir une vague, d'infléchir les courbes de croissance, et donc de limiter les facteurs de contagion, on peut toujours s'interroger sur les chiffres et ce qu'ils révèlent, ou pas. questionner n'est pas répondre, mais au moins suggérer qu'on réfléchisse, ne serait-ce que pour optimiser la stratégie... ou en changer. Pour le reste - les mesures concrètes et leur méthodologie - l'expérience nous a montré qu'on a toujours autant de mal avec la cohérence et la décentralisation, ce qui transforme l'autorité apparente de l'Etat en un édifice de plus en plus fragile. Mais c'est une autre histoire.

Le suivi de la pandémie s'organise autour de données relatives aux cas détectés (tests PCR, taux de positivité ou d'incidence etc...), des hospitalisations, des admissions en réanimation et des décès. A ces données s'ajoutent des indicateurs de tension caractérisant le degré de saturation des services hospitaliers.

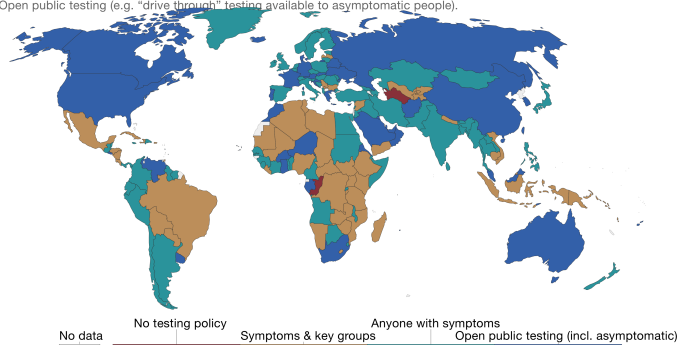
Dans la mesure où les autorités sanitaires n'estiment pas qu'une action touchant les malades symptomatiques « légers » est utile ou possible, la stratégie est clairement d'endiguer la croissance des cas et donc du niveau d'hospitalisation pour « sauver » des vies.

Les cas, ou la politique de détection

Or, cette approche conduit à s'interroger d'abord sur la politique de détection. S'agit-il de tester « ceux qui le désirent », ou seulement les personnes déclarant des symptômes ? Est-elle variable ? La réponse à cette question détermine directement le niveau global des tests, et le taux de positivité. La carte ci-contre met en évidence une réelle hétérogénéité, y compris en Europe, rendant difficile toutes

COVID-19 Testing Policies, Nov 2, 2020

- No testing policy.
- Only those who both (a) have symptoms and also (b) meet specific criteria (e.g. key workers, admitted to hospital, came into contact with a known case, returned from overseas).
- Testing of anyone showing COVID-19 symptoms.
- Open public testing (e.g. "drive through" testing available to asymptomatic people).



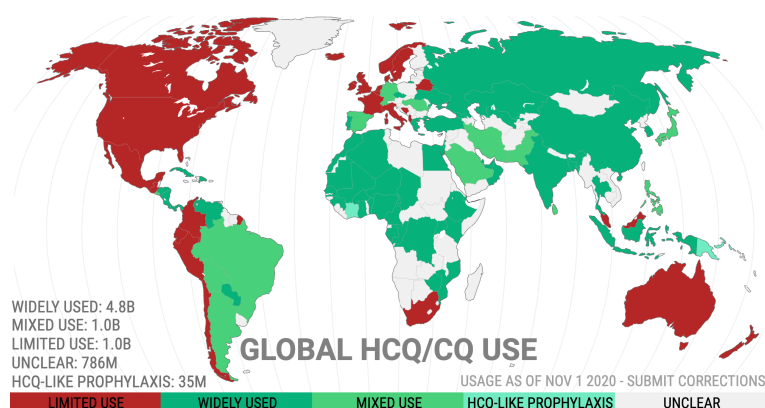
Source: Hale, Webster, Petherick, Phillips, and Kira (2020). Oxford COVID-19 Government Response Tracker – Last updated 2 November, 06:30 (London time)
OurWorldInData.org/coronavirus • CC BY

comparaison rigoureuse du nombre ou de la proportion de « cas » ou des taux de positivité ou « d'incidence ». Pourtant on en fait tous les jours.

Ce qu'on fait des cas ou la politique de soins

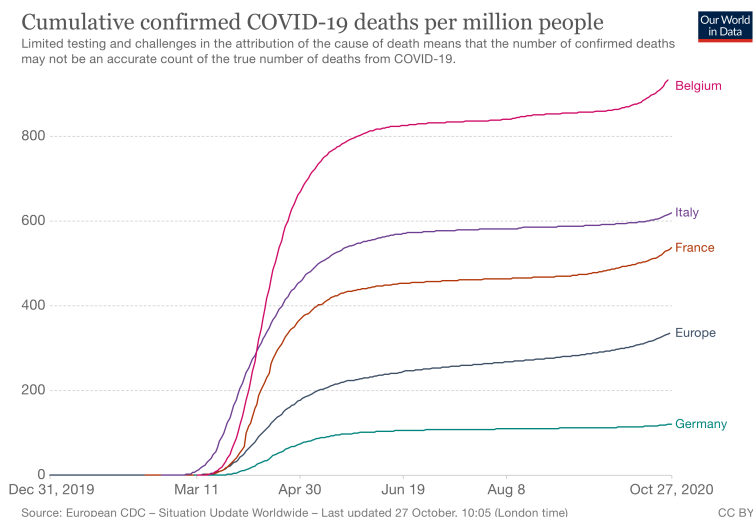
La question est alors de savoir ce qu'on fait des « cas covid19 ». La logique de détection voudrait qu'on isole les malades (lesquels ?), qu'on les traite éventuellement, après avoir confirmé à la fois (ou non) le diagnostic et le test pratiqué, tout en recherchant les personnes ayant été en contact avec le patient. La question des soins est alors centrale. Soigne-t-on avant l'hospitalisation éventuelle ? Et comment soigne-t-on ?

Les éléments publics dont nous disposons ne permettent pas de répondre à ces questions, autrement qu'à travers les témoignages publiés, l'interprétation des articles scientifiques et les « interdits » édictés par les autorités médicales. Autrement dit, pour le grand public, et pour certaines autorités de santé, nous avons largement une boîte noire, mystérieuse. Seules des indications globales et qualitatives sont publiées, comme celle où figure l'usage ou non de l'hydroxychloroquine.

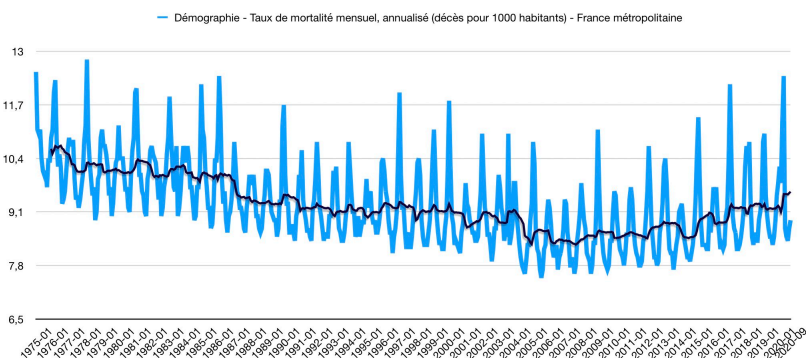


L'issue

L'indicateur ultime est celui de la mortalité générale. On sait ici aussi que la nature même de ces chiffres est discutée, en raison même du mode de saisie des morts de Covid19. Pour autant, il est possible de retracer la courbe cumulative (ou par période de temps) des morts imputées par pays. Or, il met en évidence des écarts considérables peu ou pas expliqués entre pays voisins.



En d'autres termes on aimerait pouvoir « imputer » ces différences à des facteurs (soins, système hospitalier, mesures non médicales...). Aujourd'hui on doit se contenter d'hypothèses. Il est possible enfin de s'intéresser à la mortalité « toutes causes » et de calculer l'incidence apparente de la pandémie. A ce stade il est à craindre qu'on la surestime...



Les politiques

Les choix qui viennent d'être faits par le gouvernement, consistent essentiellement à prendre des mesures de confinement pour limiter la propagation épidémique, pour faire baisser puis se retourner la pente de la courbe des admission hospitalières, et partant, en réanimation et celle des décès.

C'est en fait un double aveu :

- celui de l'absence de politique en matière de soins prophylactiques et en amont de l'hospitalisation, du maintien d'un processus de détection non ciblé, et de l'insuffisance du processus de détection et d'isolement des malades,
- et, par ailleurs celui de la fragilité (extrême) du système hospitalier face aux épidémies.

Si on peut considérer que le premier aveu relève bien de l'appréciation de l'approche médicale de la maladie du Covid19, le second est d'une nature redondante. En effet, la consultation des archives de presse met en évidence une étonnante répétition de la thématique de la saturation avant le Sars-Cov2.

Un rappel : la Redondance des crises

Mars 2018, 20 [minutes.fr](https://www.minutefr.com/) ; « Les services des **urgences** sont saturés dans plusieurs villes de France en ce mois de mars, ce qui est inhabituel à cette période de l'année. » Cette information signifierait qu'il y a des saturations « habituelles » par ailleurs.

« Selon des chiffres fournis par le ministère de la santé le 16 mars dernier, 97 hôpitaux sur les 650 - publics ou privés - qui ont une structure d'urgences avaient, au 13 mars, activé le **plan « hôpital en tension »**. Une information reprise par le Quotidien du Médecin.

Janvier 2017, Le [figaro.fr](https://www.lefigaro.fr/) ; La grippe est en cause. « En trois jours, on est passé de 86 à 142 établissements qui avaient déclenché le dispositif **hôpital en tension** », constate Anne-Marie Armanteras de Saxcé, la directrice générale de l'offre de soins.

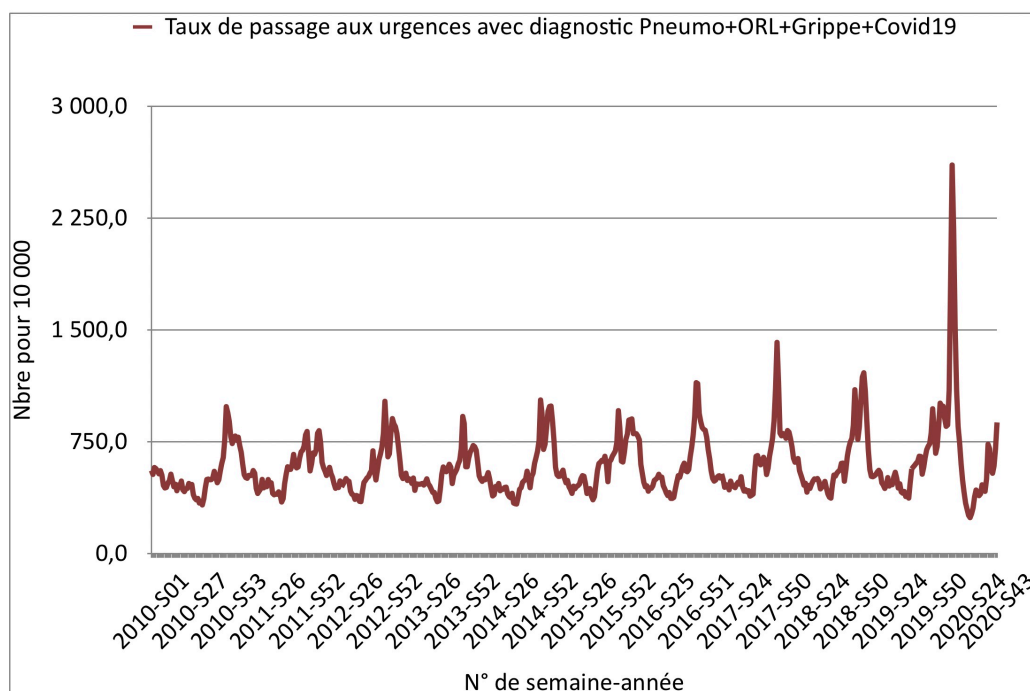
Février 2015, Le point.fr ; « *Le Samu-Urgences de France et l'Association des médecins urgentistes de France (Amuf) ont dénoncé jeudi une "situation sanitaire critique" dans les hôpitaux, surchargés en raison de l'épidémie de grippe, et réclame au gouvernement la réouverture de lits.*

La "*sur-saturation des services d'urgence est comparable à celle de l'été 2003*", où la canicule avait fait 15.000 morts, a estimé auprès de l'AFP le président du Samu-Urgences de France François Braun. Une infographie parle de 600 000 nouveaux cas dans la semaine du 9 au 15 février et de 728 cas graves en réanimation.

Février 2012, L'Express ; « *L'épidémie de grippe a conduit à une "saturation" des services d'urgences depuis dix jours en France, prévient l'Association des médecins urgentistes de France (Amuf). "L'hôpital est au bord de la crise de nerf"*, écrit-elle dans un communiqué, en demandant à être reçu "en urgence" par le ministre du Travail et de la Santé Xavier Bertrand pour "trouver des solutions immédiates". » Décembre 2005, Ecole Nationale de la Santé Publique. Un rapport de stage s'intitule « *La saturation chronique des lits de médecine en question. (...)* » Le rapport parle, à propos de Saint Briec, d'embolisation récurrente.

Peut-on mettre des données face à ces alertes ?

Les chiffres de Santé Publique France, nous permettent (réseau @Oscour) de suivre chaque semaine les passages aux urgences selon les pathologies. Ce réseau représente plus de 90 % des urgences en France. En relevant les urgences relatives aux diagnostics de pneumopathie, d'affections ORL, de grippe et de Covid19, on prend en compte un spectre large d'infections des voies supérieures. Cela permet alors de mettre des chiffres en face des articles de presse. Le premier graphique figure le nombre d'affections indiquées pour 10 000 patients passant aux urgences. On discerne clairement la grande pointe de celles-ci au printemps 2020, ainsi que la proportion élevée de celles-ci de manière périodique, « saisonnière ». On remarque qu'il y a bien une saisonnalité de ces affections par delà certaines anomalies.

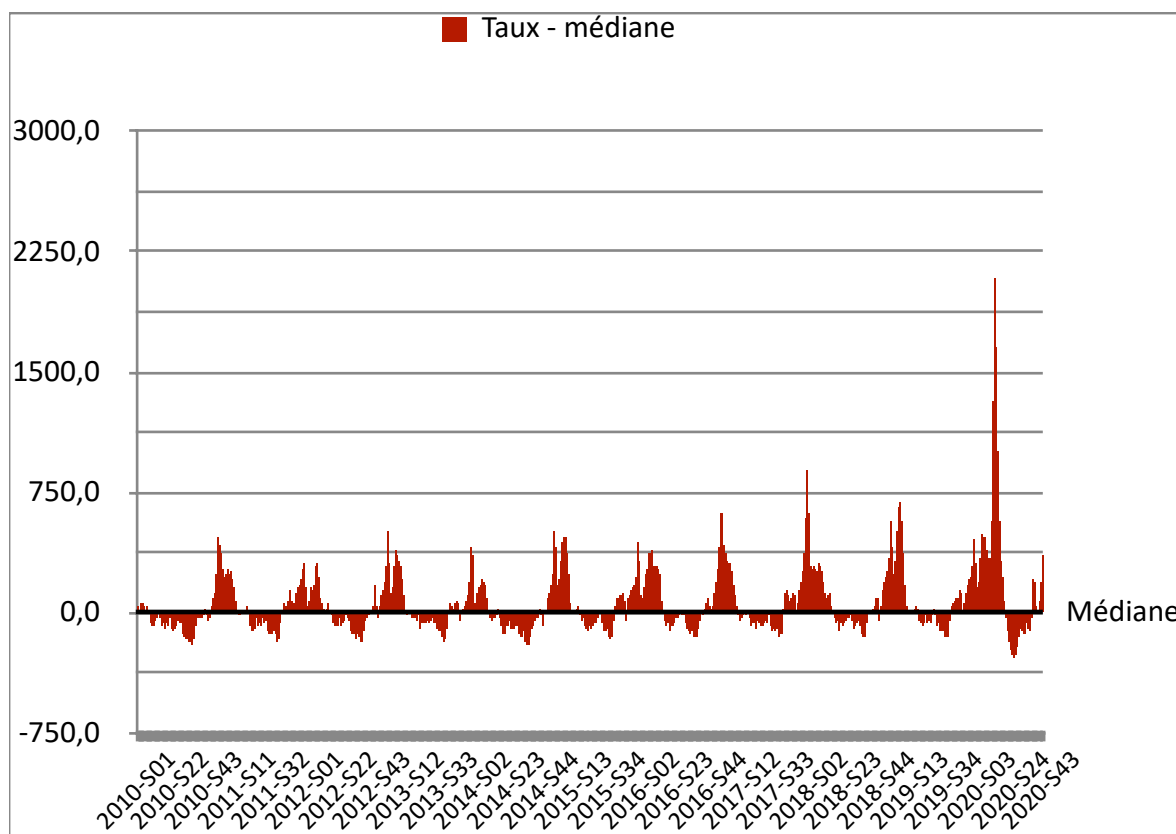


On peut bien entendu filtrer les semaines affichant plus de 10 % des passages liés à ces affections.

Il apparaît alors clairement que la part prise par ces affections dans les passages aux urgences n'a dépassé 10 % que moins de 20 semaines en 10 ans, et seulement 7 années. En revanche l'apparition du Covid19 a bien modifié significativement la gestion des urgences avec des taux dépassant 13 % à 4 reprises.

On peut enfin calculer un indicateur de tension en calculant l'écart à la médiane des parts prises par ces pathologies dans les passages (5,24 %). L'hyper tension des urgences lié au Covid19 apparaît donc comme résultant d'une majoration de la pointe d'environ 15 points, ce qui est relativement peu.

Courbe de l'écart à la moyenne du nombre de passages d'affections des voies supérieures



aux urgences pour 10 000

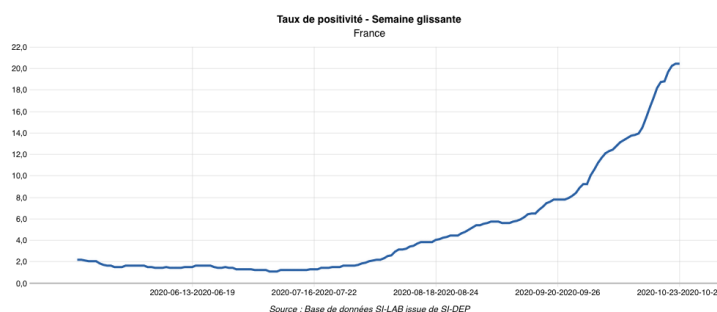
On peut en conclure raisonnablement que le système est - dans son état actuel et dans le cadre des protocoles actuellement appliqués - d'une grande fragilité redondante, ce qui, face à l'inconnu (croissance forte sans échéance connue), provoque une panique évidente dès lors

qu'on ne traite pas en amont de l'hôpital. La chose est sans doute pire au stade des réanimations.

Dynamique

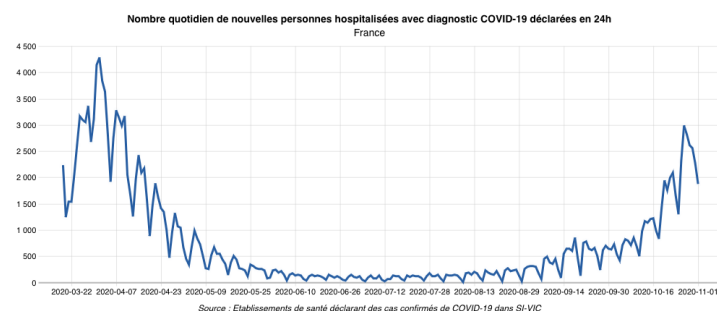
Mais revenons à la dynamique des données. La méthode de test en France, non ciblée, permet, sous réserve d'une représentativité des personnes testées, d'évaluer un taux de positivité et son évolution. Nous savons que sa progression est - parmi d'autres données - à l'origine du nouveau confinement.

Le taux de positivité en semaine glissante est en effet passé de 4 % fin Aout à 20 % environ fin octobre, et suit une courbe clairement exponentielle.



Parallèlement, le nombre d'hospitalisation suit une évolution sensiblement comparable à partir de juin.

Or, nous pouvons empiriquement relier à ce chiffre le niveau des admissions en réanimation, et le nombre de décès. L'amélioration des soins hospitaliers permet désormais d'espérer une mortalité plus faible. Pour autant, si le système hospitalier est frappé d'embolie, il se dégraderait inexorablement.



Stratégie

C'est donc là l'élément ultime de réflexion, qui justifie le retour au confinement.

Bien évidemment on peut logiquement discuter le détail des mesures choisies par le gouvernement, tout comme leur caractère national et non différencié. Mais on en perçoit parfaitement la logique.

Revenons cependant sur les éléments de la logique mise en oeuvre.

Certains éléments ne peuvent hélas être remis en cause globalement. Par exemple la vitesse de transformation et de renforcement du système hospitalier peut être accélérée, mais il faut du temps pour atteindre des objectifs ambitieux. Le système de santé, comme un système de transport ou de communication, doit disposer d'une sur-capacité pour faire face aux pointes !

En revanche la politique de détection peut être changée, la politique de soins en amont de l'hospitalisation comme celle menée à l'hôpital peut être modifiée, et selon certains réanimateurs, la pratique de réanimation également transformée. Et au lieu d'être aveugle face à nombre d'expériences menées en France ou à l'étranger, il conviendrait de s'inspirer de ce qui est efficace. Ce que l'on ne fait pas toujours, et que l'on se trouve même combattre parfois. D'où cette idée que, la politique gouvernementale est finalement, une sorte de choix par défaut de stratégie.